Dịch tễ học HIV/AIDS

Văn Đình Hòa_BM DTH

vandinhhoa@hmu.edu.vn

Mục tiêu của bài học

1. Trình bày được quá trình tiến triển tự nhiên của nhiễm HIV/AIDS
2. Trình bày được các tác động của đại dịch HIV/AIDS
3. Trình bày được các phương thức lây và không lây truyền HIV
4. Trình bày được các phương thức dự phòng nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam
5. Trình bày đặc điểm Dịch tễ học HIV/AIDS tại Việt Nam

MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN

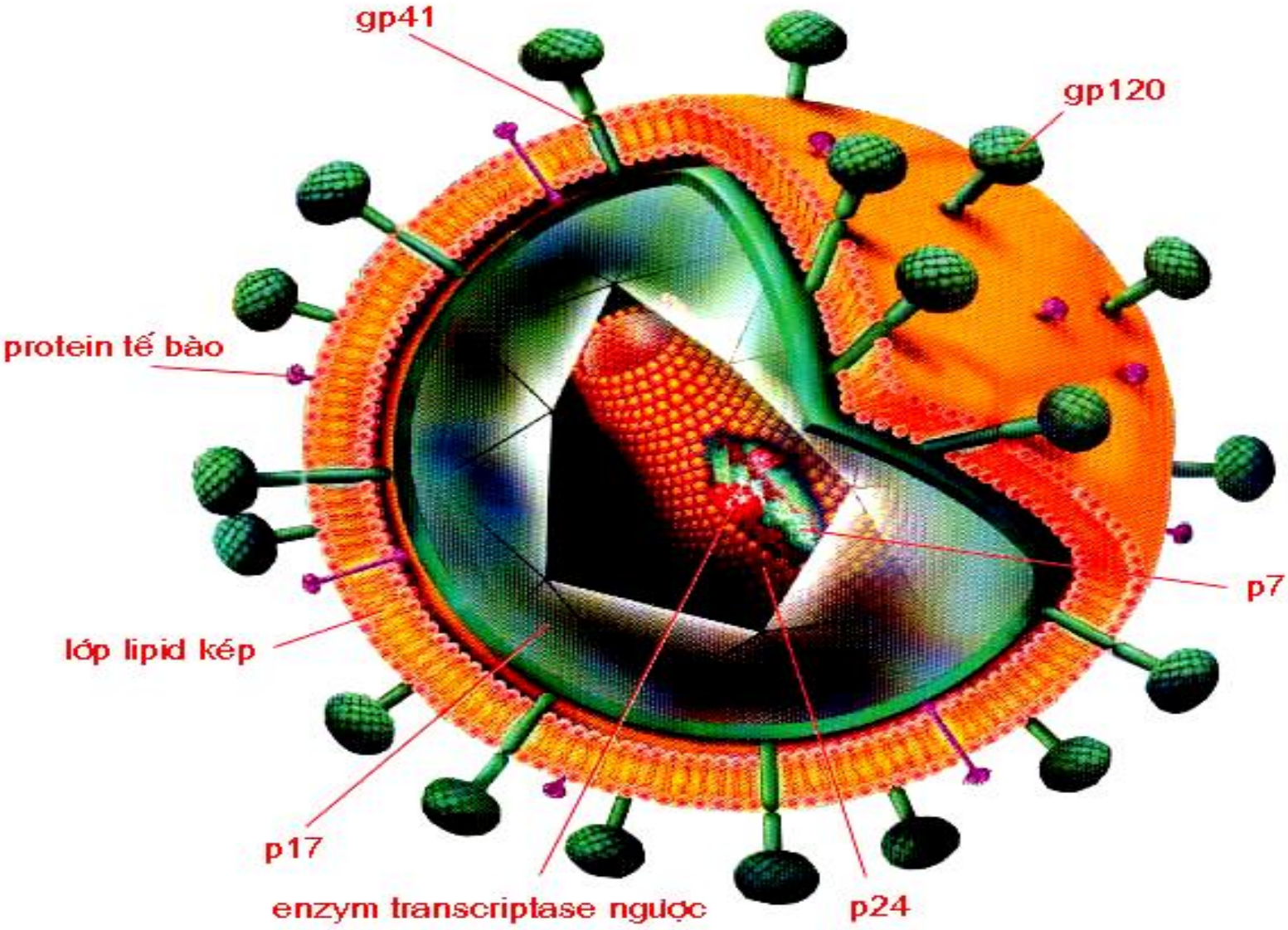
I. Lịch sử phát hiện HIV và AIDS

- **HIV**: viết tắt của Humman Immunodefiency Virus
- **AIDS**: viết tắt của Acquired Immuno Deficiency Syndrome: hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
- 1981: 5 ca viêm phổi do Pneumocistis Carinii ở người MSM khoẻ mạnh.
- Tháng 5/1983: Luc Montagier và cộng sự ở Viện Pasteur Paris lần đầu tiên phân lập được vi rút gây AIDS ở Trung Phi

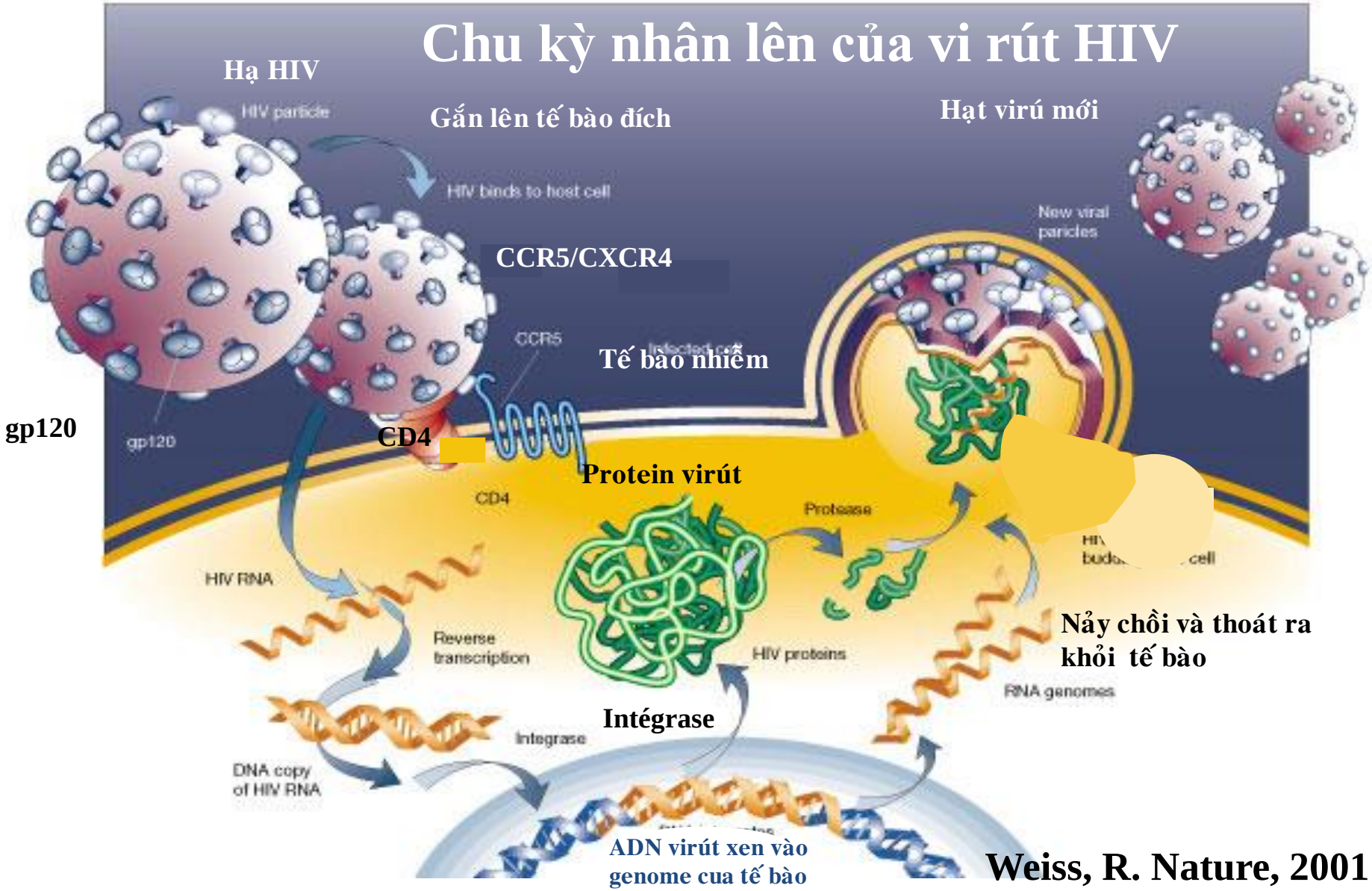
I. Lịch sử phát hiện HIV và AIDS

- Tháng 3/1985: Kỹ thuật xét nghiệm phát hiện kháng thể HIV được phát triển
- Tháng 7/1985: Thuốc điều trị AIDS đầu tiên được phát hiện là Azidothymidine (AZT).
- Ngày 01/02/1987, Chương trình phòng chống AIDS toàn cầu đã được thiết lập
- Tại Việt Nam, quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

CẤU TRÚC CỦA HIV

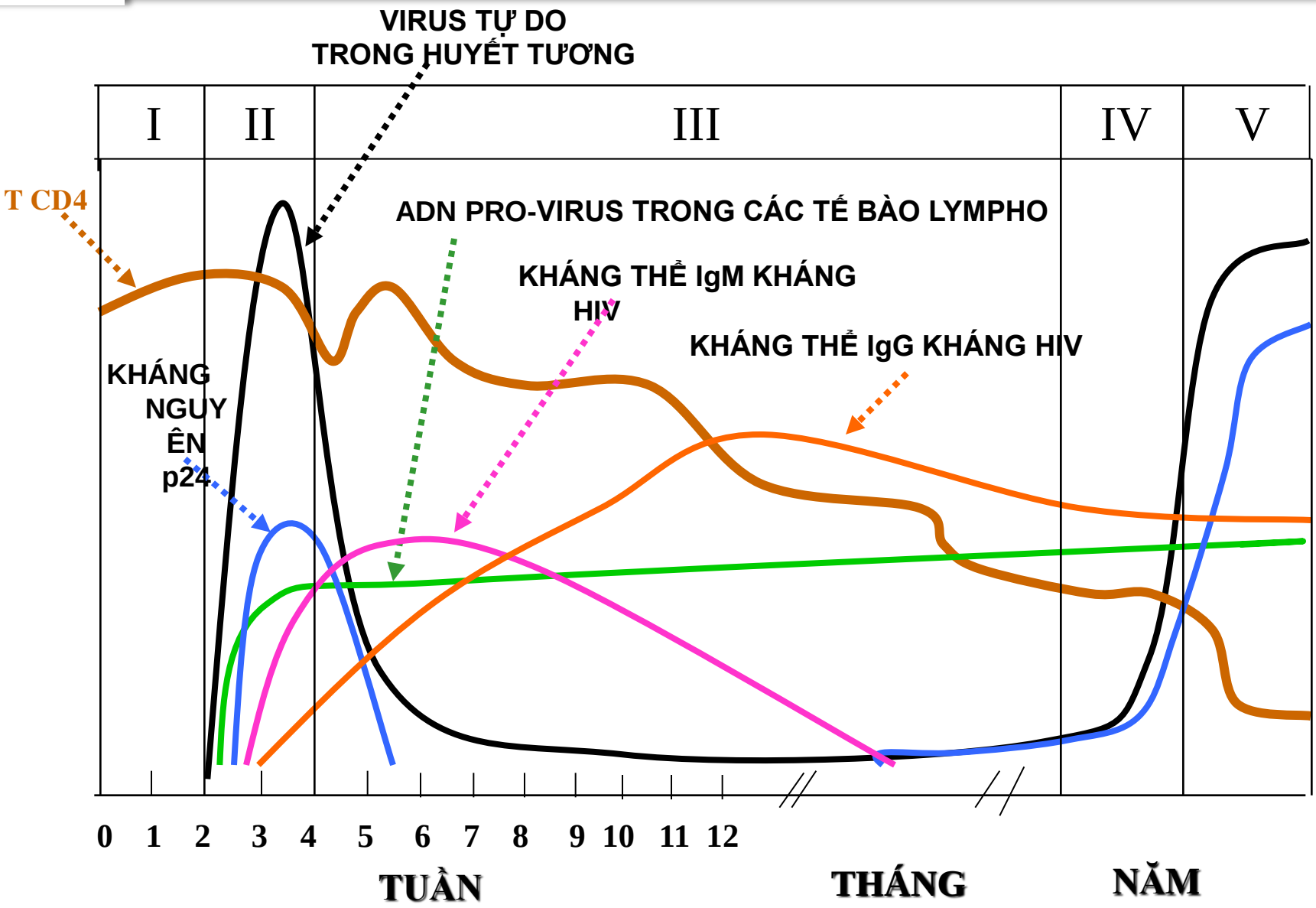


II. Quá trình tiến triển của nhiễm HIV



Weiss, R. Nature, 2001

II. Quá trình tiến triển của nhiễm HIV



II. Quá trình tiến triển của nhiễm HIV

Giai đoạn 1: không triệu chứng: có 2 thời kỳ:

- Thời kỳ sơ nhiễm HIV: xảy ra sau khi nhiễm vài tuần, vài tháng, triệu chứng giống của một nhiễm vi rút thông thường khác: sốt, hạch to, phát ban
- Thời kỳ "im lặng": kéo dài 8-10 năm, khỏe mạnh, không có biểu hiện gì, có thể lây truyền.

II. Quá trình tiến triển của nhiễm HIV

Giai đoạn 2: Triệu chứng lâm sàng nhẹ

- Sút cân không rõ nguyên nhân (< 10% trọng lượng cơ thể sau 1 tháng).
- Viêm hầu họng, viêm mũi
- zona, viêm da bã nhờn, nhiễm nấm móng
- viêm miệng tái diễn
- phát ban sẩn ngứa...

II. Quá trình tiến triển của nhiễm HIV

Giai đoạn 3: Triệu chứng tiến triển

- Sút cân không rõ (> 10% trọng lượng cơ thể)
- Tiêu chảy, sốt không rõ nguyên nhân
- Nhiễm nấm Candida miệng tái diễn
- Lao phổi
- Nhiễm trùng nặng do vi khuẩn
- Viêm loét miệng hoại tử cấp, viêm lợi
- Thiếu máu (Hemoglobin < 80g/l), giảm bạch cầu trung tính hoặc giảm tiểu cầu mãn tính.

II. Quá trình tiến triển của nhiễm HIV

Giai đoạn 4: Triệu chứng nặng hay còn gọi là AIDS

- Hội chứng suy mòn (Sụt cân > 10%, sốt> 1 tháng hoặc tiêu chảy > 1 tháng không rõ nguyên nhân)
- Sưng hạch, đặc biệt ở cổ và nách.
- Ho kéo dài, viêm phổi do Pneumocystic Carinii
- Lao ngoài phổi
- Nấm miệng
- Candida thực quản hoặc phế quản, phổi
- Nhiễm trùng huyết tái diễn...

III. PHƯƠNG THỨC LÂY NHIỄM HIV

Người ta đã phân lập được HIV từ:

- Máu;
- Tinh dịch, dịch tiết từ âm đạo và các dịch cơ thể khác;
- Sữa mẹ;
- Nước bọt, nước mắt, nước tiểu.

Lây nhiễm HIV phụ thuộc vào:

- Số lượng vi rút HIV trong máu/dịch thể;
- Đường vào của HIV (qua da xây xước hay niêm mạc);
- Thời gian tiếp xúc;
- Sức đề kháng (hay miễn dịch) của cơ thể;
- Độc tính hay tính gây nhiễm của vi rút.

III. PHƯƠNG THỨC LÂY NHIỄM HIV

1. Đường máu: tỉ lệ lây nhiễm cao

- Lây truyền trong chăm sóc y tế
  - Dụng cụ: nhổ răng, mổ, tiêm chích
  - Ghép tạng
  - Truyền máu: người cho máu ở gđ cửa sổ
  - Phơi nhiễm nghề nghiệp

III. PHƯƠNG THỨC LÂY NHIỄM HIV

2. Đường tình dục:

- Quan hệ khác giới và đồng giới
- Qua những xây xát nhỏ trong đường sinh dục mắt thường không nhìn thấy
- Nguy cơ lây nhiễm từ 0.1%-1%, người nhận tinh trùng nguy cơ nhiễm cao hơn.
- Liên quan chặt chẽ đến bệnh STI.

III. PHƯƠNG THỨC LÂY NHIỄM HIV

3. Lây truyền từ mẹ sang con

– Lây truyền trong 3 giai đoạn: mang thai, chuyển dạ và sinh, cho con bú.

III. PHƯƠNG THỨC LÂY NHIỄM HIV

4. Những đường không lây nhiễm

- Không lây qua đường hô hấp như ho, hắt hơi.
- Không lây truyền qua tiếp xúc sinh hoạt thông thường ở nơi công cộng: cơ quan, trường học, rạp hát, bể bơi, nơi chơi thể thao.
- Không lây truyền qua bắt tay, ôm hôn, sử dụng điện thoại nơi công cộng mặc chung quần áo, dùng chung các dụng cụ ăn uống như bát đĩa, cốc chén.
- Muỗi đốt không làm lây truyền HIV.

IV. DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV

1. **Phòng lây HIV qua đường truyền máu:**

- Giảm sử dụng máu toàn phần;
- Sàng lọc người cho máu trước khi xét nghiệm;
- Thực hiện vô trùng trong chăm sóc y tế.

2. **Phòng lây qua đường tiêm chích:**

- Chương trình trao đổi bơm kim tiêm
- Chương trình cung cấp methadone
- Giảm sử dụng đường tiêm chích
- Tiệt trung kim tiêm và dụng cụ tiêm chích

IV. DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV

3. Phòng lây qua đường tình dục:

- Giảm số bạn tình
- Thực hành tình dục an toàn
- Triển khai chương trình cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su
- Triển khai chương trình điều trị các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.
- Sử dụng màng ngăn có chất diệt tinh trùng

IV. DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV

4. Dự phòng lây truyền mẹ con

- Tư vấn, phòng các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục
- Xét nghiệm sàng lọc HIV trước khi cưới
- Tư vấn và xét nghiệm HIV
- Điều trị ARV cho mẹ và con
- Cân nhắc cho bú bình hay bú mẹ

V. NGUY CƠ TIỀM TÀNG LÂY NHIỄM BỆNH

- Là bệnh truyền nhiễm mãn tính, người bệnh trở thành nguồn lây suốt đời, ủ bệnh kéo dài, chưa có vaccine và thuốc chữa khỏi.
- Lây nhiễm HIV liên quan mật thiết với hành vi nguy cơ rất khó thay đổi, dễ phát sinh phân biệt đối xử.
- Nhiễm HIV liên quan đến di biến động dân cư, phân hóa giàu nghèo

V. NGUY CƠ TIỀM TÀNG LÂY NHIỄM BỆNH

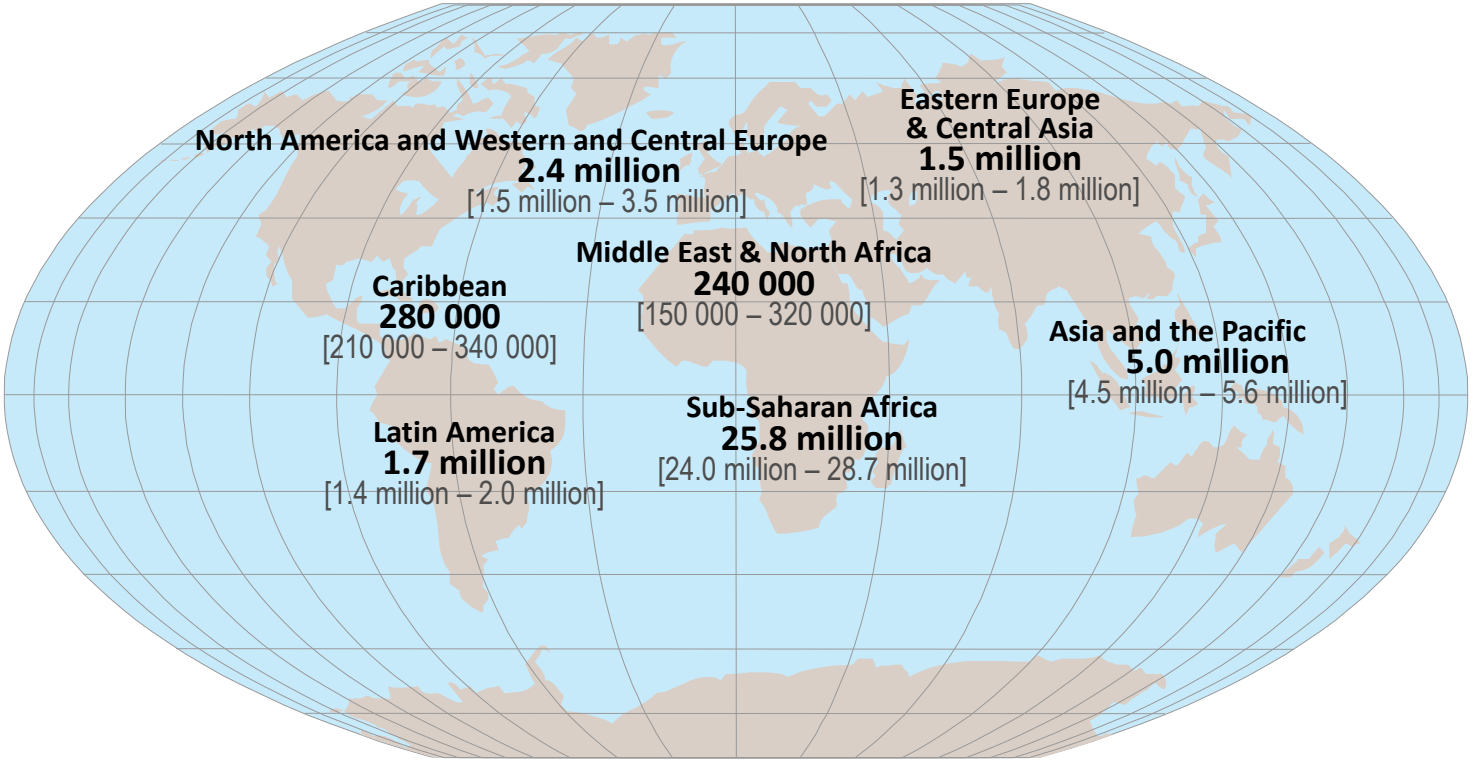
- Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường
  - Phân hóa giàu nghèo tăng lên
  - Sự di dân từ nông thôn ra thành phố
- Việt nam gần khu vực 'Tam giác vàng" là nơi sản xuất ma tuý lớn nhất thế giới, buôn bán và vận chuyển ma túy
- Sự gia tăng các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, đặc biệt là ở thanh thiếu niên.

V. NGUY CƠ TIỀM TÀNG LÂY NHIỄM BỆNH

- Số báo cáo các bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng
  - Ước tính 700.000-1.200.000 bệnh nhân.
  - Đa số đi khám tư → không nhận được chẩn đoán và điều trị phù hợp
- Lan truyền HIV qua khu vực biên giới với Trung quốc, Lào, Campuchia, qua các nhóm gái mại dâm, người buôn bán, thương gia, người NCMT

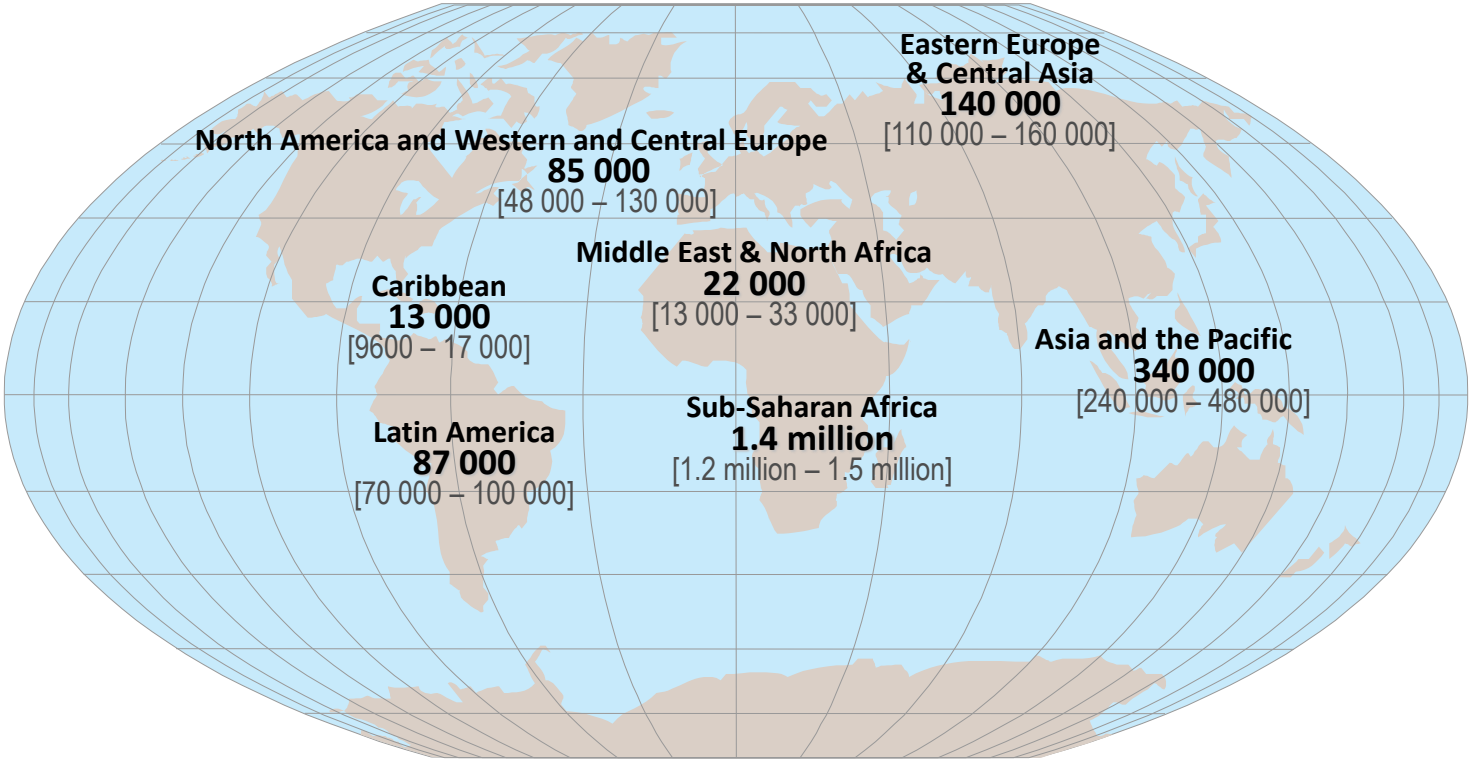
DỊCH TỄ NHIỄM HIV/AIDS

Ước tính số người nhiễm HIV còn sống trên thế giới | 2014



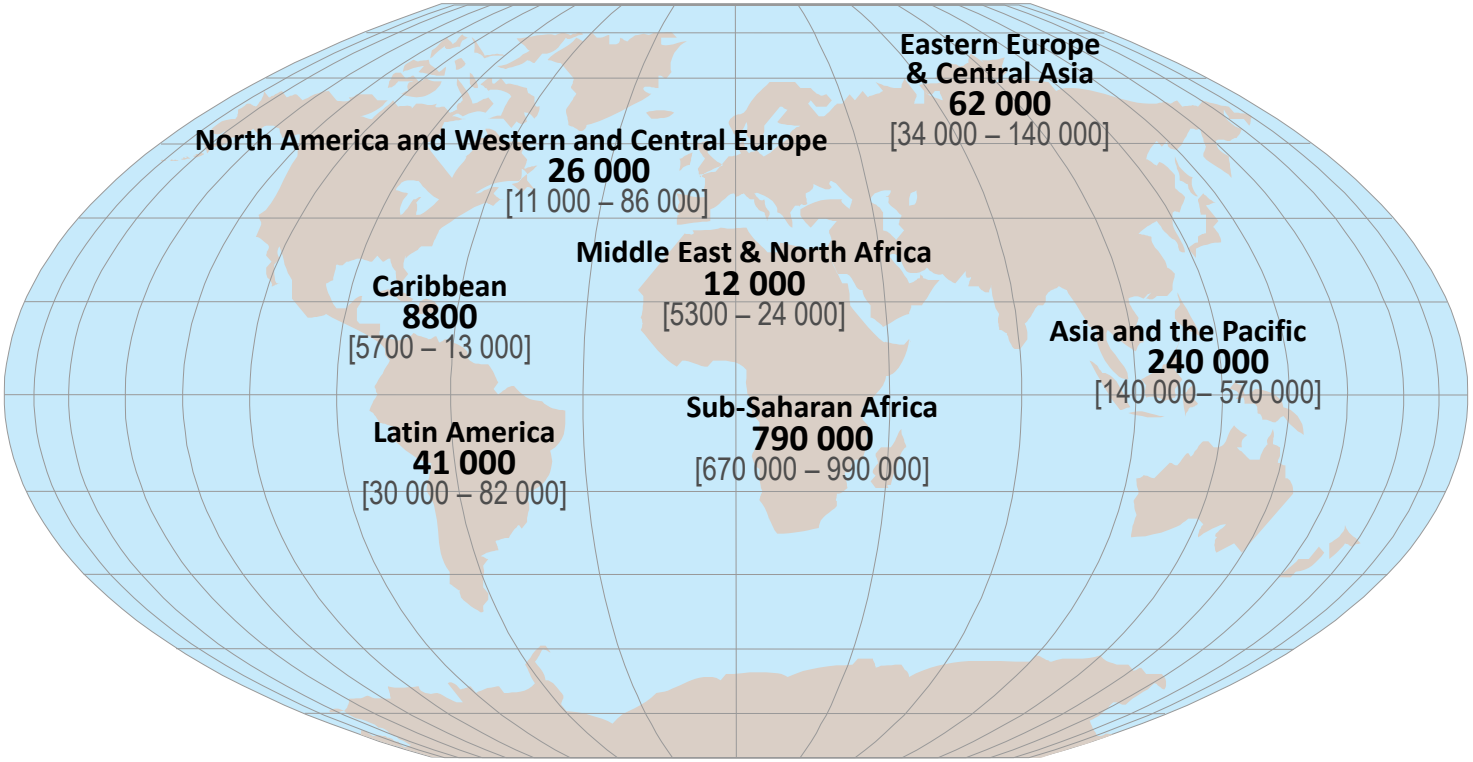
Tổng cộng: 36.9 triệu [34.3 triệu – 41.4 triệu]

Ước tính số trẻ em và người lớn mới nhiễm HIV | 2014



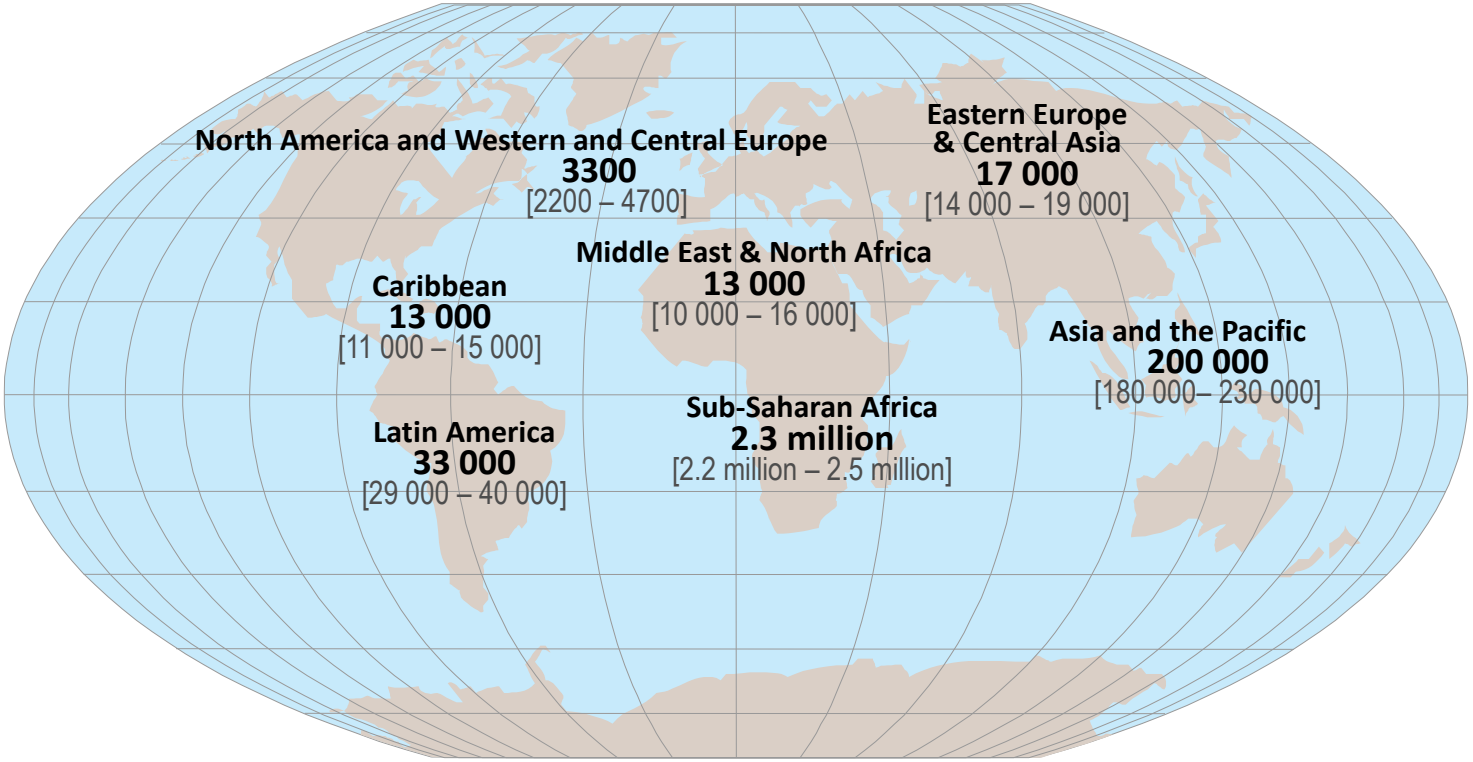
Tổng cộng: 2.0 triệu [1.9 triệu – 2.2 triệu]

Ước tính số người lớn và trẻ em chết do AIDS năm 2014



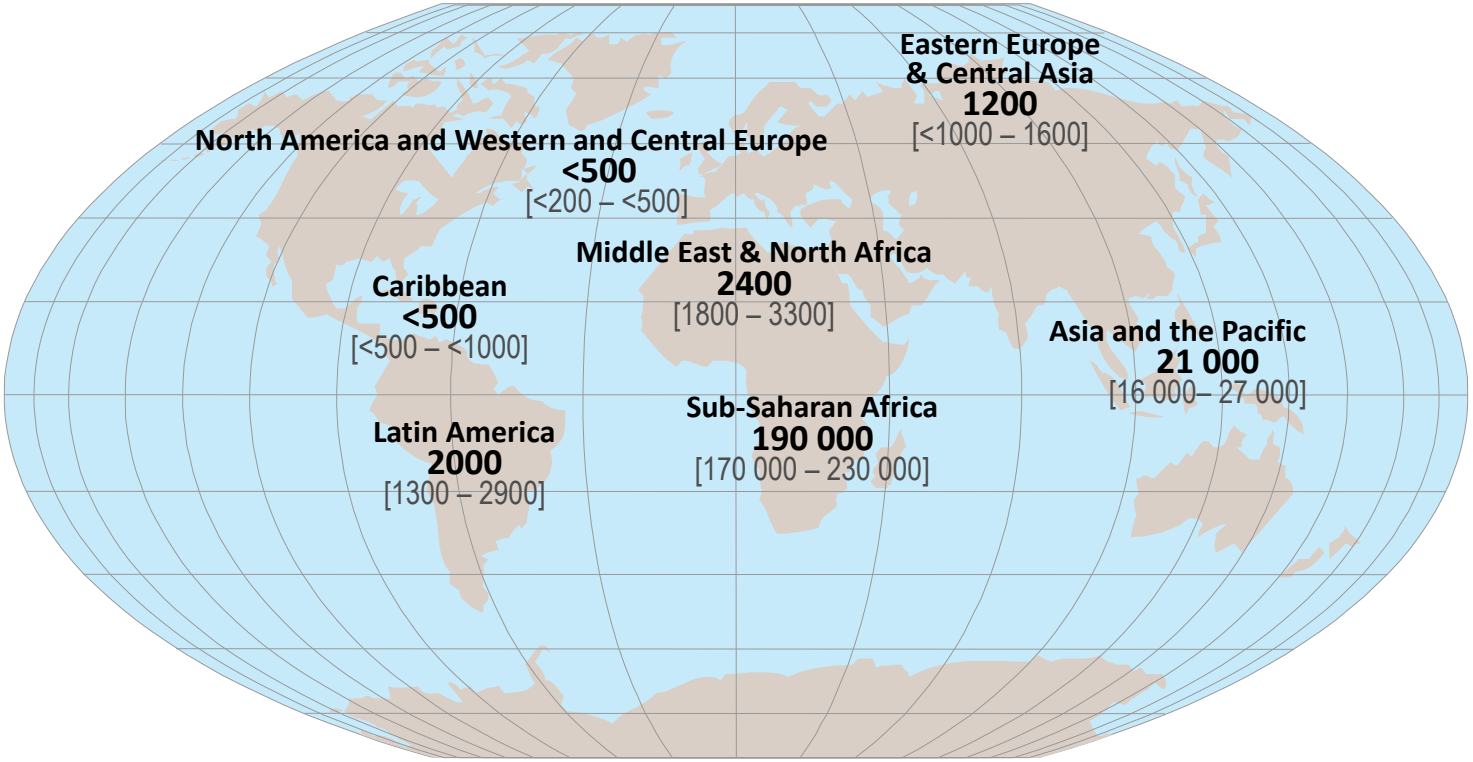
Total: 1.2 million [980 000 – 1.6 million]

Ước tính số trẻ em <15 tuổi nhiễm HIV còn sống năm 2014



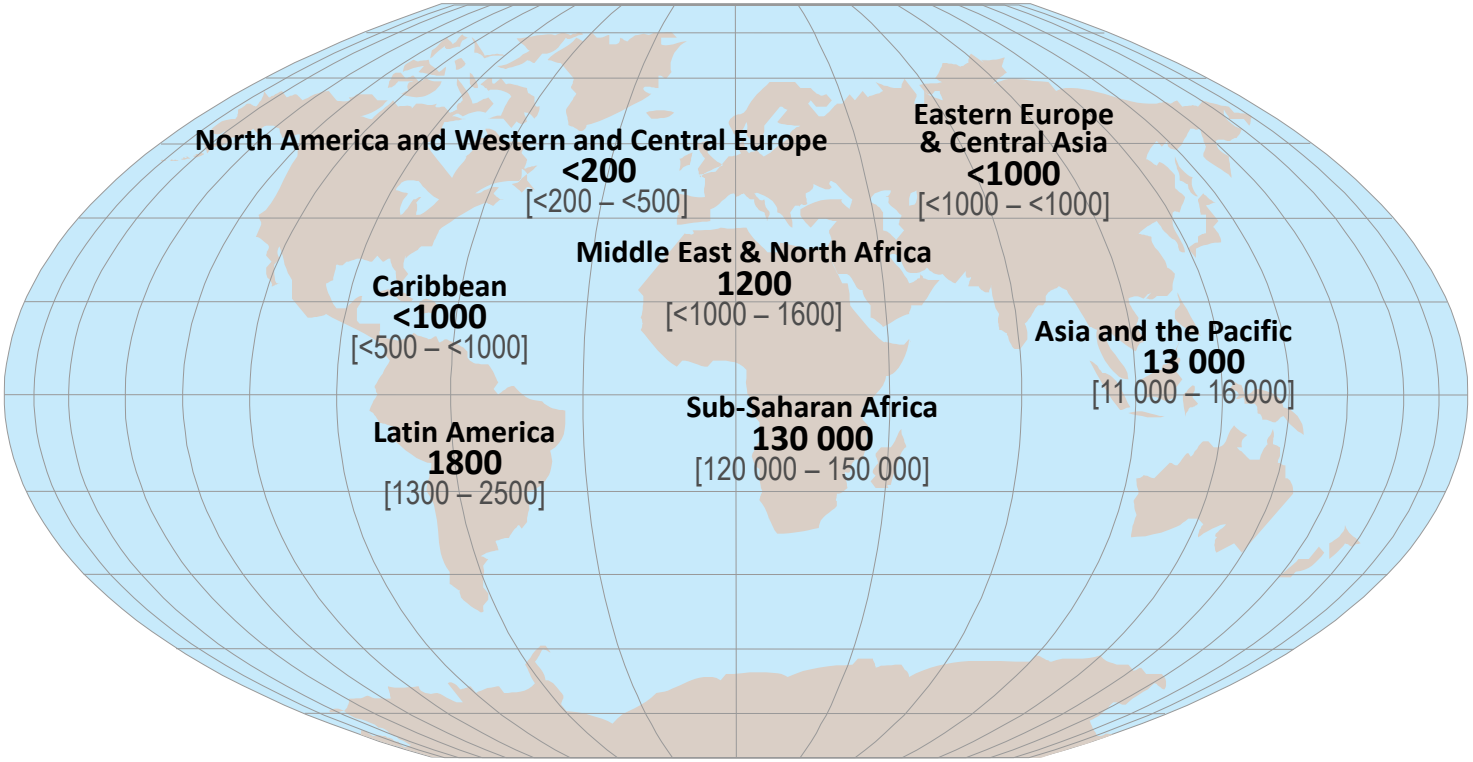
Total: 2.6 million [2.4 million – 2.8 million]

Ước tính số trẻ em <15 tuổi mới nhiễm HIV năm 2014



Tổng cộng: 220 000 [190 000 – 260 000]

Ước tính số trẻ em <15 tuổi chết do AIDS năm 2014



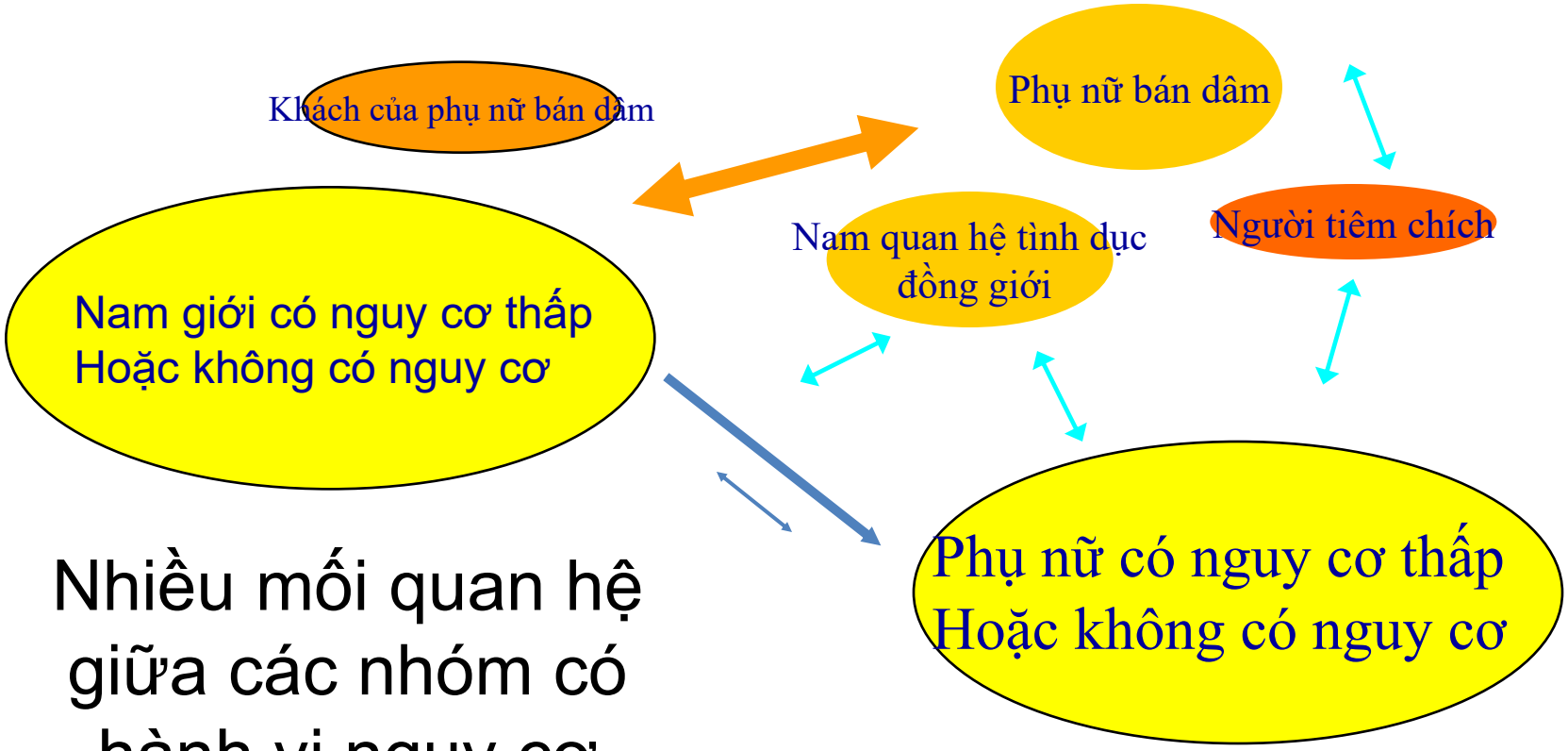
Tổng cộng: 150 000 [140 000 – 170 000]

Khoảng 5.600 trường hợp mới nhiễm HIV mỗi ngày năm - 2014

- **Khoảng 66% ở Sub-Saharan Africa**
- **Khoảng 600 là trẻ em dưới 15 tuổi**
- **Khoảng 5.000 từ 15 tuổi trở lên, trong đó:**
  - **gần 48% là phụ nữ**
  - **khoảng 30% là người trẻ (15-24 tuổi)**

Dịch tễ học HIV/AIDS tại Việt Nam

MÔ HINH DỊCH HIV/AIDS Ở CHÂU Á

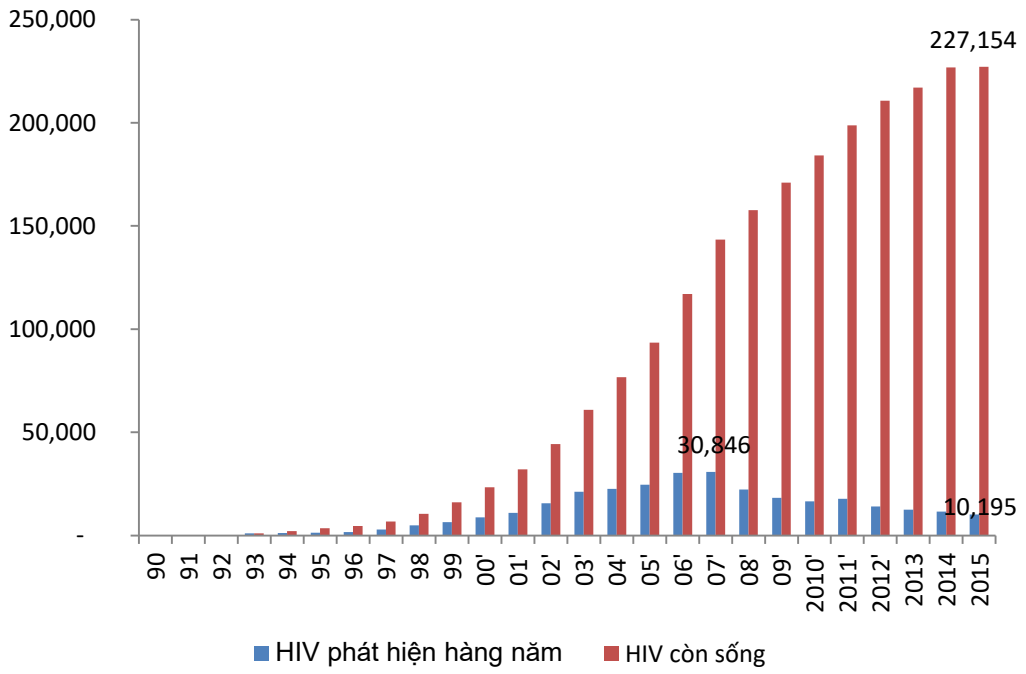


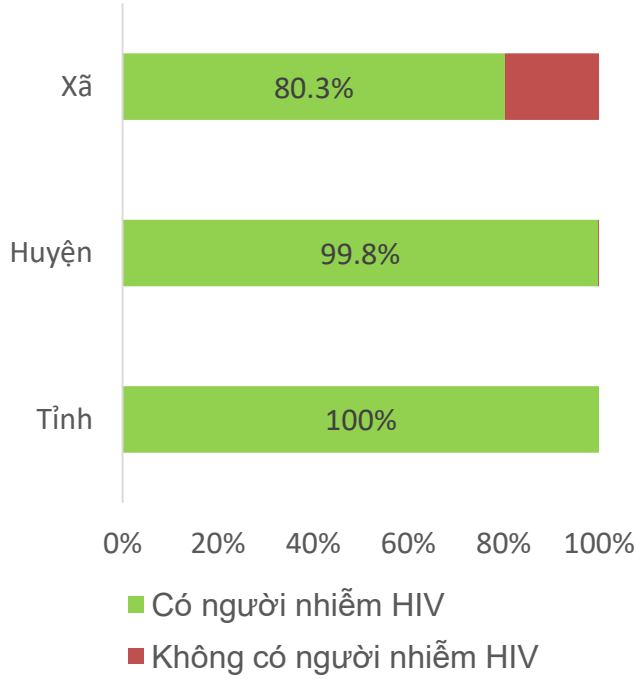
Nhiều mối quan hệ giữa các nhóm có hành vi nguy cơ cao

Source: Adapted from Tim Brown's presentation

BÁO CÁO SỐ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

	2015	Đến 12/2015
• Số HIV phát hiện mới:	10.195	
• Số bệnh nhân AIDS:	6.130	85.194
• Số HIV đã tử vong:	2.130	86.716





HÌNH THÁI DỊCH HIV/AIDS THAY ĐỔI

Phân bố người nhiễm HIV là nữ gia tăng

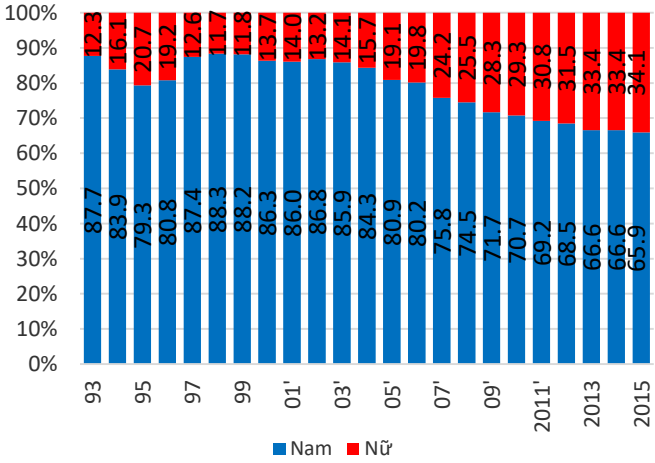
10% → 34.1%

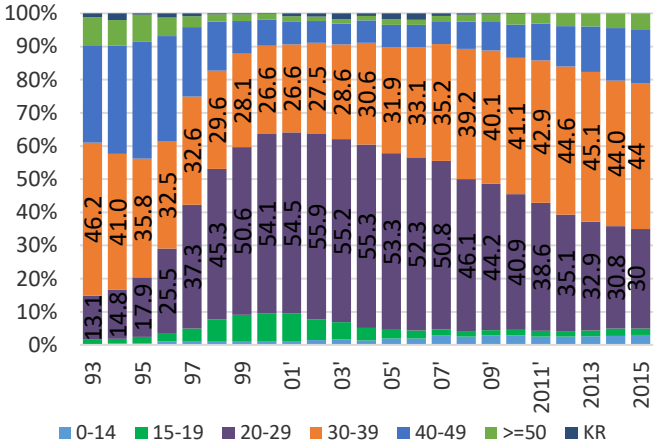
Đa số là độ tuổi 20-40

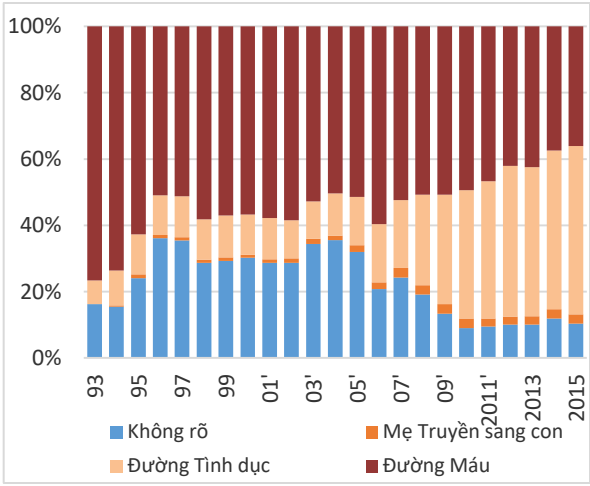
80%

Phân bố người nhiễm HIV lây qua đường tình dục gia tăng

10%→ 50.8%

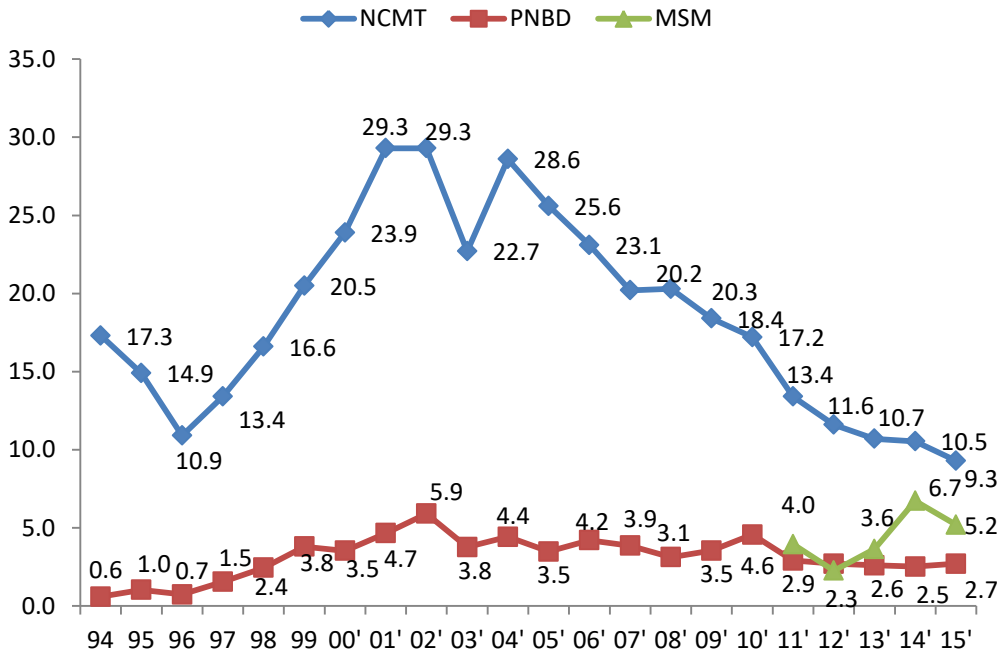




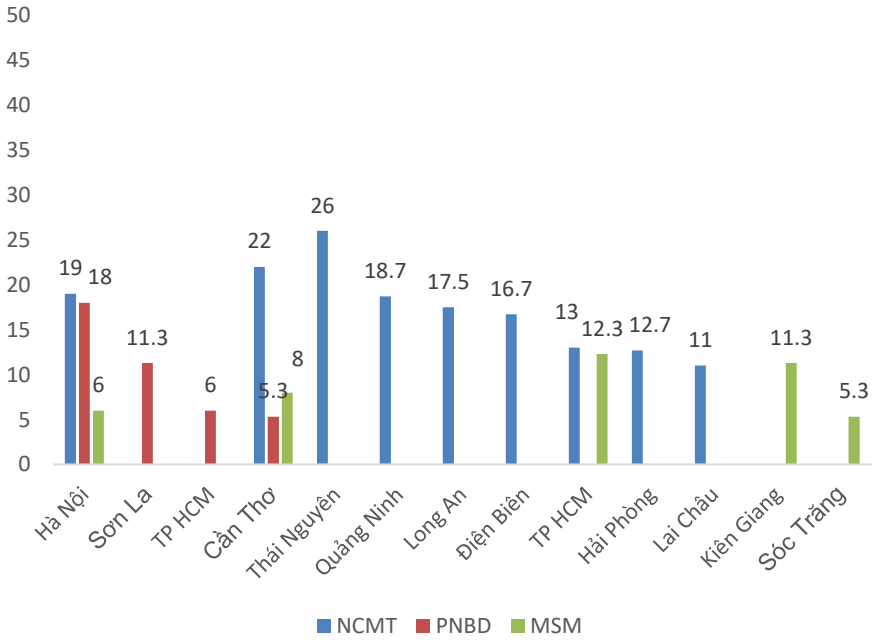


Tỷ lệ nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao

Tỷ lệ nhiễm HIV trong các nhóm NCC tính chung toàn quốc qua các năm

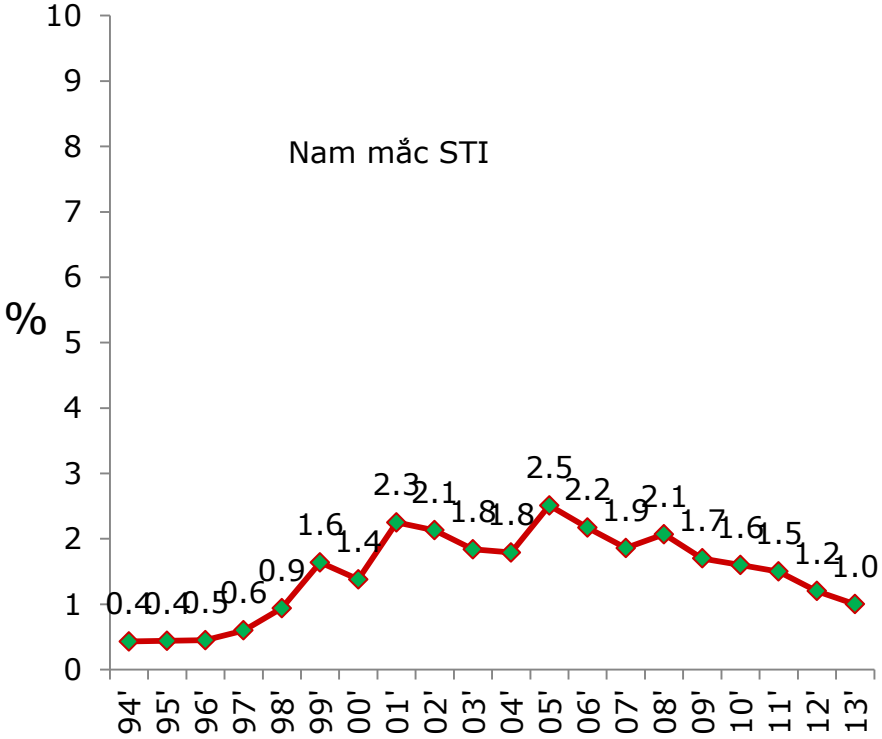


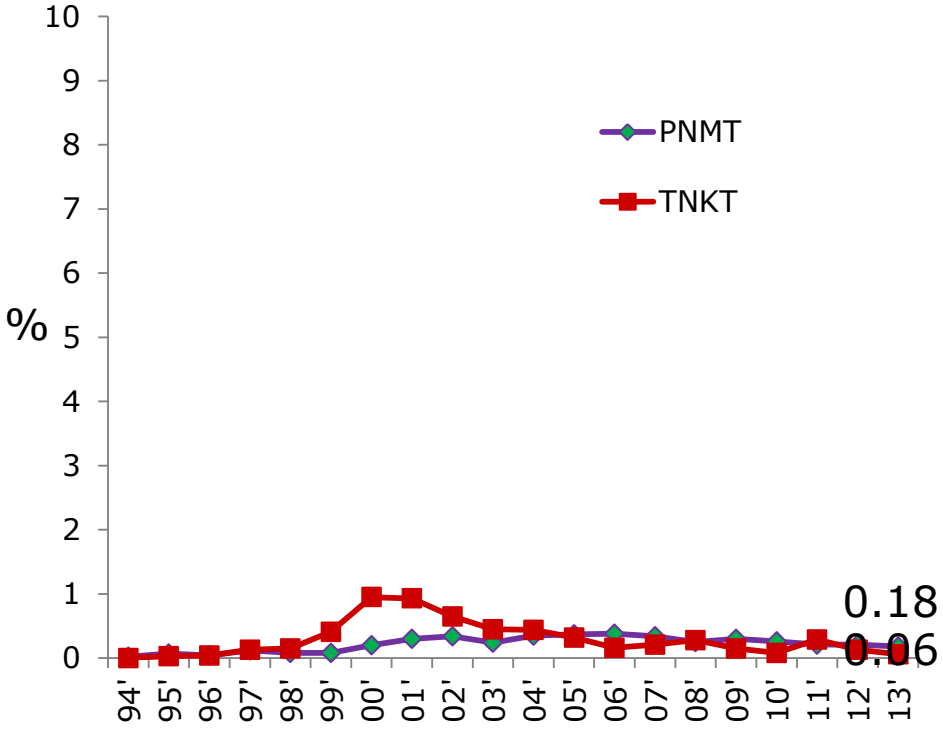
Một số tỉnh có tỷ lệ nhiễm HIV cao ở các nhóm



Nguồn: HSS 2015

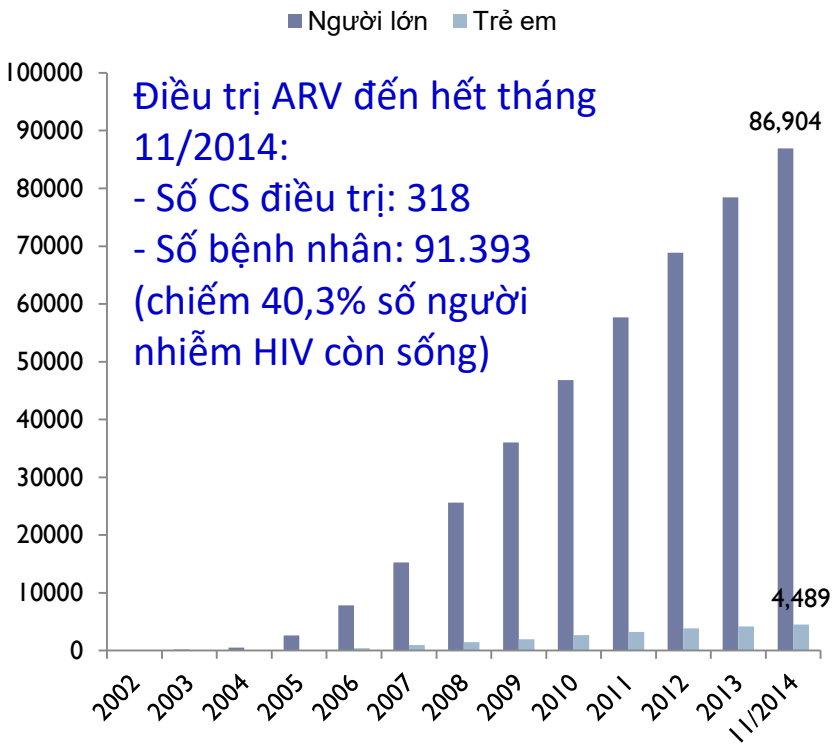
Nhiễm HIV trong nhóm STI, phụ nữ mang thai và TNKTNVQS





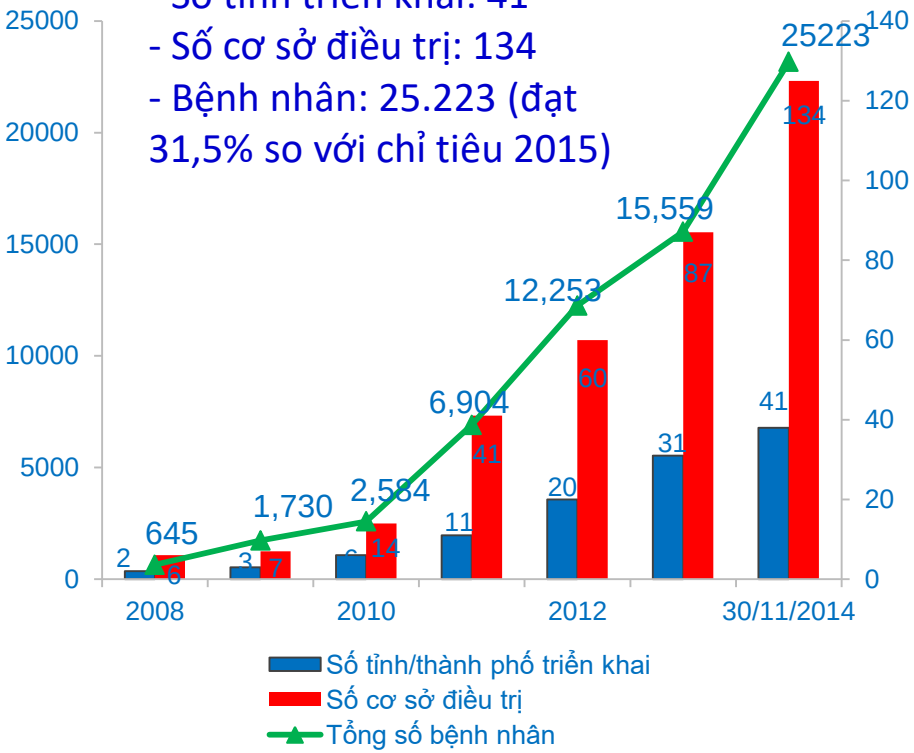
Nguồn: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Kết quả triển khai các chương trình phòng, chống HIV/AIDS



Điều trị ARV đến hết tháng 11/2014:
- Số CS điều trị: 318
- Số bệnh nhân: 91.393 (chiếm 40,3% số người nhiễm HIV còn sống)

Điều trị MMT đến hết tháng 11/2014:
- Số tỉnh triển khai: 41
- Số cơ sở điều trị: 134
- Bệnh nhân: 25.223 (đạt 31,5% so với chỉ tiêu 2015)



Mục tiêu điều trị HIV

90%

số người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của bản thân

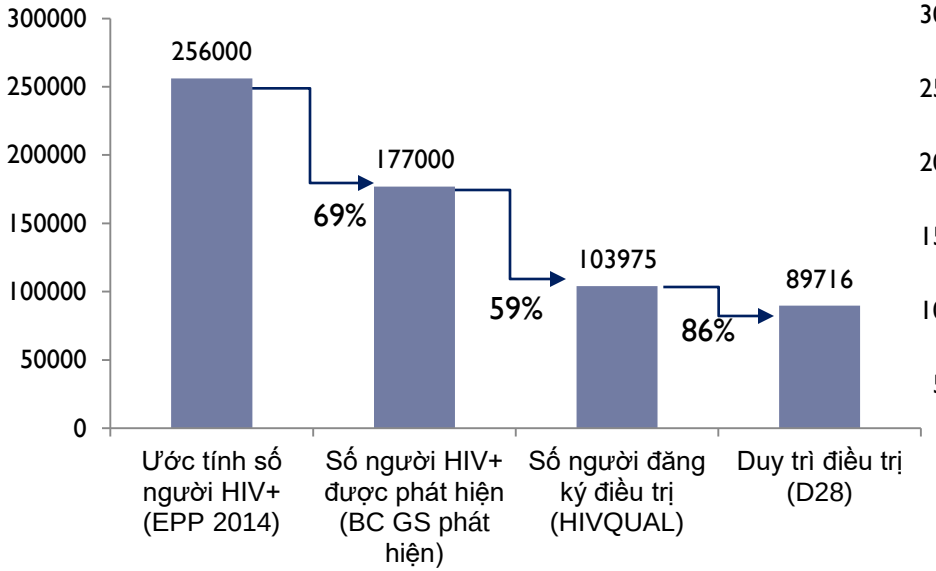
90%

số người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời

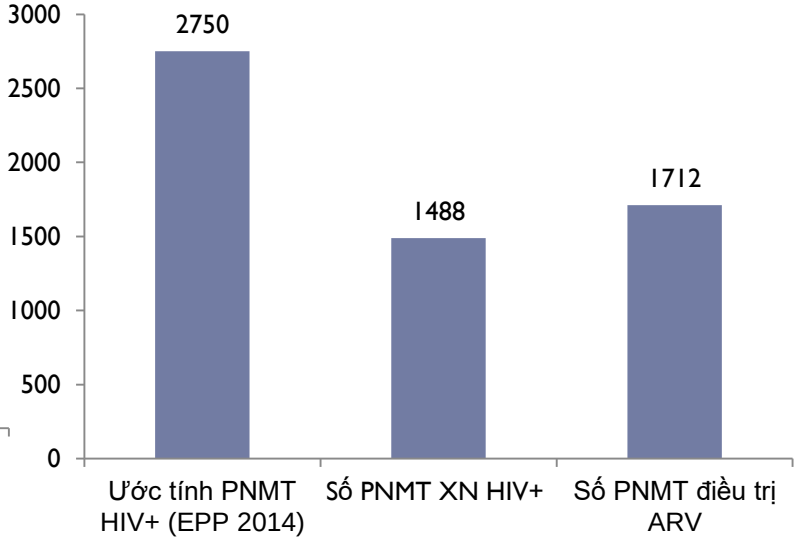
90%

số người điều trị ARV duy trì tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế

Kết quả triển khai các chương trình phòng, chống HIV/AIDS



Mô hình đa bậc về chăm sóc điều trị



Điều trị dự phòng lây truyền mẹ con

Tác động của dịch HIV/AIDS

1. **Dân số**: điển hình là ở Sahara Châu Phi:

- 1/3 người ở độ tuổi quan hệ tình dục nhiễm HIV
- Tỷ lệ trẻ em chết tăng ngược trở lại do HIV/AIDS
- Tỷ lệ tử vong của người lớn tăng gấp 3 lần trong vòng 5 năm

2. **Xã hội:**

- Phân biệt đối xử
- Ruồng bỏ
- Không được chăm sóc
- Mất việc làm
- Sợ hãi
- Tăng chi phí khám chữa bệnh
- Giảm thu nhập

Tác động của dịch HIV/AIDS

3. Gia đình

- Cấu trúc gia đình bị tan vỡ
- Làm cho các gđ có người nhiễm HIV bị nghèo hóa
- Gia đình có người nhiễm HIV/AIDS
  - Bị cô lập trong cộng đồng,
  - Cảm giác xấu hổ, mặc cảm
- Tăng gánh nặng cho người phụ nữ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng

4. Cộng đồng:

- Cộng đồng người nghèo chịu ảnh hưởng nhiều nhất
- Tăng các dịch vụ cộng đồng cả ở nông thôn và thành thị.
- Tăng gánh nặng cộng đồng

Tác động của dịch HIV/AIDS

5. Xã hội:

- Làm phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc
- Tăng chi phí và chăm sóc XH:
  - Người già không nơi nương tựa
  - Trẻ em không người chăm sóc
- Tăng các dịch vụ XH nhất là khi dịch đã lan tràn rộng
  - Dịch vụ thuốc men
  - Chăm sóc,
  - Dịch vụ tư vấn
  - Bao cao su,...

Tác động của dịch HIV/AIDS

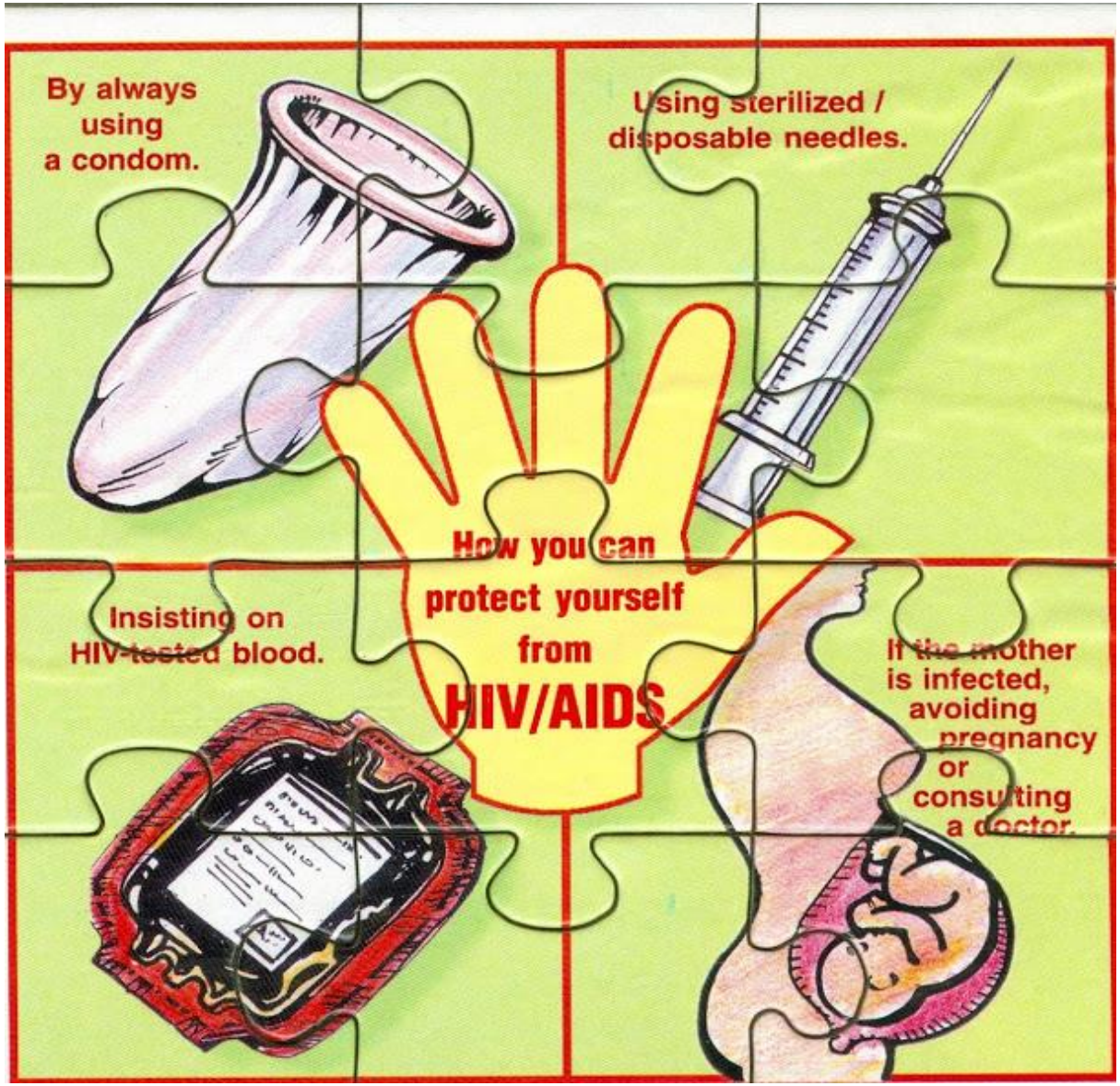
6. Chính trị:

- Gây bất ổn về chính trị do làm suy yếu quân đội
  - Tân binh trong quân đội bị nhiễm HIV/AID.
- Các nước nghèo
  - Vốn phụ thuộc rất nhiều vào các nước giàu có
  - Đại dịch HIV/AIDS đã làm cho chúng càng trở nên kiệt quệ
  - Dễ bị phụ thuộc hơn cả về kinh tế, chính trị.

7. Kinh tế:

- Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng BV không đủ để đáp ứng
- Lao bùng phát trở lại
- Kinh phí dùng cho việc điều trị những nhiễm khuẩn cơ hội

XIN CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE!



Q & A